

☒ ACOMPANHAMENTO		☐ CONSULTA	
NS 22231696433		707	
ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO			
IDADE: 75	PESO: 83	ALTURA: 1,68	PROFISSÃO: Bancário (aposentado)
SINTOMAS: <i>Awake durante o dia, despertares noturnos, insônia, sonhos presenciais.</i>			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: <i>Tapiriz 10 / Lorazepam.</i>			
MÉDICO: <i>Dr. Luiz Fernando F. Gama Filho (cardio)</i>			
MARCAPASSO: ☐ S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ☐ S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>4-5x semana (caminhada)</i>			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: <i>5</i>		ALMOÇO: <i>5</i>	LANCHE: <i>N</i> JANTAR: <i>19:30-20h</i>
HORA QUE DORME: <i>22:30-23h</i>		HORA QUE ACORDA: <i>5:30-6h</i>	
COCHILHO: ☐ S ☒ N	DORME ACOMPANHADO: ☒ S ☐ N ☐ EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: ☒ S ☐ N / DORMEM NO QUARTO: ☐ S ☒ N		PET NO QUARTO: ☐ S ☒ N	
BEBIDA ALCOÓLICA: ☐ S ☐ N X NA SEMANA ☒ N			
FUMO: ☐ S ☐ N MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>nasal</i>		BANHEIRO/NOITE: <i>1x</i>	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>não</i>	MALLAMPATI: <i>III</i>	IAH: <i>66,5 e/h</i>	SPO2: <i>80%</i>
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>HAS / doença xpto ①</i>			
CIRURGIAS: ☐ NASAL ☐ AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: ☐ RESPIRATÓRIA ☒ ENDÓCRINA ☐ CARDÍACA			
☐ ORTOPÉDICA		☐ NEUROLÓGICA ☐ OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: ☐ S ☐ N		SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
<i>maxe Wisp silicone</i>			
24/10/24 <i>Análise</i>			
31/10/24 <i>P=8,1 cmH₂O / fixado 8,0 cmH₂O</i>			
<i>IAH=1,7 e/h</i>		<i>Oriento usar tecido</i>	
<i>mde uso: 7h12'</i>		<i>sobre o nariz pois pele</i>	
<i>fuq: 0</i>		<i>está sensível e aperto</i>	
		<i>mascara</i>	
		<i>Natasha</i>	
07/11/24 <i>P=8 cmH₂O</i>			
<i>IAH=1,4 e/h</i>		<i>Bem adaptada</i>	
<i>mde uso: 6h6'</i>		<i>Natasha</i>	
<i>fuq: 0</i>			
28/11/24 <i>P=8 cmH₂O</i>			
<i>IAH=1,5 e/h</i>		<i>melhora dos sintomas e</i>	
<i>m. de uso: 6h12'</i>		<i>não está despertando.</i>	
		<i>comprei o CPAP</i>	
		<i>fuq.</i>	

20/12
2024

P: 8 cmH₂O
IAH = 1,1 e/h
m. de uso: 6 horas
fuga: 5 l/min

Bem adaptado.

lesão de pele naiz

* comprou máscara Dream Ulean (M) *

Silvia

07/02/25 P: 8 cmH₂O
IAH = 1,1 e/h
m. de uso: 7 h 1'
fuga: 4,0 l/min

Bem adaptado
Ficou 1 semana intubado
por pneumonia

16/04
25 P: 8 cmH₂O
IAH = 1,2 e/h
m. de uso: 6 h 30'

patada

- Houve melhora do quadro
de despertares e insônia.
- filtro



DR.
**LUCIANO
ROTELLA**

OTORRINOLARINGOLOGIA E SONO

Dr. Luciano Rotella

Título de Especialista em
Otorrinolaringologia.
ABORL - CCF

Especialista em Medicina
e Biologia do Sono - AMB

Graduação médica - UNIFESP
Escola Paulista de Medicina.

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOVA, Antonio Monteiro Sobrinho
EX/AM nº: 4602
SOLICITADO POR: Dr. Luiz Fernando Fagundes de Gouveia Filho
DATA: 11/09/2024
IDADE: 75 anos

Comentários:

Solicito para tratamento de SAOS

CID: G47.3

() CPAP com pressão titulada de _____ cm H₂O

() BIPAP com pressão insp de _____ cm H₂O e exp _____ cm H₂O

(x) CPAP com pressão sugerida de 8 cm H₂O e
relatório após 20 dias de uso

Dr. Luciano Rotella
Otorrinolaringologista
CRM 111556

(12) 3923-4000

Avenida 9 de Julho, 765,
1º Andar, Ed. Apollo Center,
São José dos Campos

www.drucianorotella.com

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Antonio Monteiro Sobrinho

EXAME nº: 5602

SOLICITADO POR: Dr. Luiz Fernando Fagundes de Gouvêa Filho

DATA: 11/09/2024

IDADE: 75 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h18min e concluído às 06h01min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o estágio REM, de 69 minutos. O tempo total de sono foi de 332 minutos (05h32min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 72,4%. A distribuição do sono registrado mostrou 32,7% de estágio 1, 49,5% de estágio 2, 0,5% de estágio 3 e 17,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 118 minutos em vigília, ocorreram 185 microdespertares (índice: 33,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 35,2/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 66,5/hora, sendo 19,2 apneia/hora e 47,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 68,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 90%, sendo a média de 92% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (66,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (68,7/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal – observei esporádicas extrassístoles. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 74 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

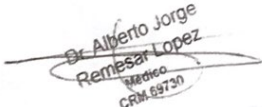
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (69 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 72,4%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 33,4/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (32,7%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 3 (0,5%; normal: 10-12%) e REM (17,3%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (49,5%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (35,2/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008


Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730